

Nombre: ADER MANUEL

Protocolo: A310022

Fecha protocolo: 16/07/2026

Solicitado por: --

INMUNOFENOTIPIFICACION

MATERIAL

Médula ósea.

METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína peridínclorofílica (PerCP), (PerCP Cy5.5) y alofococianina (APC), tándem APC-H7, tándem PECy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de flujo FACScantoII utilizando los software FACS DIVA e Infinicyt.

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:

- * Linfocitos Totales: 3.6 %
- * Plasmocitos: < 0.1 %
- * Monocitos: 0.4 %
- * Gr. neutrófilos: 49.9 %
- * Gr. eosinófilos: < 0.1 %
- * Gr. basófilos: < 0.1 %
- * Células CD117+/CD34(-): 1.8 %
- * Eritrocitos nucleados: 38.5 %
- * Células dendríticas: < 0.1 %

CELULAS PATOLOGICAS

*5.8% blastos mieloides de tamaño mediano CD45+, CD34-/+, HLA-DR++, CD117+, CD38++, CD13++, CD16(-), CD11b(-), CD10(-), CD71+, CD64(-), CD14(-), CD36(-), CD105(-), CD33+, CD15-/+, CD56(-), CD7-/+(37%).

OBSERVACIONES

*Gr. Neutrófilos marcados rasgos dishemopoyéticos en los patrones de maduración CD13/CD16/CD11b/CD35/CD10.

*Escasos monocitos muy escasos sin alteraciones fenotípicas.

*Serie eritroide aumentada con expresión heterogénea de CD36 y CD71.

CONCLUSIONES

Presencia de blastos mieloides similares a los antecedentes (5.8%) con marcados signos displásicos en línea gr. Neutrófilo y serie eritroide. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

Dra. Paula Temptra
Bioquímica
MN 9824

Dra. Andrea Novoa
Bioquímica
MN 8693